

护士协作专业答复

生成时间：2026-05-29 19:24:42

陈萍忠老人D5护理评估与周任务指导报告

一、评估结论

基于返院第5天（D5）综合评估，陈萍忠老人当前处于**高跌倒风险、中度服药依从性挑战及认知干预不足**状态，具体如下：

- **跌倒与二次头部外伤高风险****：存在明确危险因素组合——近期（2025年11月）头部外伤史伴右额部皮下血肿、阿尔茨海默病致环境判断力下降、平地行走需部分辅助、使用奥氮平及劳拉西泮等镇静类药物（已由AI评估确认）、潜在体位性低血压（历史记录DBP=60mmHg）。夜间如厕无陪护为关键漏洞。
- **规律服药面临行为症状阻碍****：BPSD表现为拒绝配合康复及集体活动，可能延伸至拒药行为；当前多重用药方案（含多奈哌齐、美金刚、他汀类、抗精神病药及镇静剂）存在潜在相互作用及骨髓抑制风险（历史WBC/PLT偏低），亟需确保依从性以避免治疗中断或不良反应。
- **认知干预强度不足****：虽基础生活照料规律，但康乐活动频次偏低（仅上午安排），未能充分利用其“喜好跳舞”的个人特质进行非药物干预，不利于情绪稳定与认知功能维持。

二、周重点任务（D5 – D11）

围绕跌倒防护、规律服药、认知干预三大核心，制定以下可执行任务：

1. **跌倒防护强化措施**

- 实施**24小时防跌倒监护**：夜间如厕必须全程一对一陪护，床旁加装感应夜灯及扶手；日间转移/行走时使用助行器并确保照护员在侧。
- 每日晨起及午睡后执行**卧立位血压监测**（记录卧位5分钟、立位1分钟及3分钟血压），筛查体位性低血压。

- 浴室改造：铺设防滑垫、调低水温上限（ $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ），洗澡全程由固定照护员协助，避免独处。

2. **规律服药保障策略**

- **服药监督机制**：所有口服药由护士直接看服到口，记录实际服药时间及反应；对拒药行为采用“分散给药法”（将药物分次融入餐食或饮品，需医生确认可行性）。
- **家属协同教育**：向子女说明当前用药必要性及风险（尤其镇静剂与跌倒关联），获取其对监督服药的支持承诺。
- **用药审查准备**：本周内预约药师会诊，评估药物相互作用，优先考虑简化镇静剂方案（如劳拉西泮减量）。

3. **认知干预优化计划**

- **个性化活动设计**：每日下午15:00 – 15:30安排“怀旧舞蹈疗法”（播放其年轻时熟悉的舞曲，鼓励坐姿律动或简单手势模仿），利用其跳舞喜好提升参与意愿。

- ****减少被动等待时间****：在上午康乐活动外，增加午后感官刺激（如触摸箱、音乐盒），避免长时间静坐加剧BPSD。

-

****正向激励记录****：对任何主动参与行为即时口头表扬并记录，用于后续干预方案调整。

****三、D5数据录入规范****

请于今日（D5）完成以下结构化录入，确保信息完整可追溯：

- ****血压/血脂数据****：在“慢性病管理”模块录入住院前、出院时及今日（D5）的收缩压、舒张压、总胆固醇、LDL-C数值（若缺失历史值，标注“未提供”而非留空）。

- ****BPSD行为记录****：在“精神行为症状”栏详细描述拒绝康复/集体活动的具体表现（如言语抗拒、肢体推开）、发生时段及持续时间。

- ****跌倒风险评估****：更新Morse量表及Hendrich

II量表评分，特别注明“使用镇静剂”“步态不稳”“认知障碍”三项高危因素。

- ****服药执行日志****：逐项记录每剂药物名称、剂量、实际服药时间、是否拒药及处理措施（如“劳拉西泮2mg 20:30 看服到口，无拒药”）。

****四、风险观察要点****

本周需重点监测以下预警信号，发现异常立即上报：

- ****二次头部外伤征象****：头痛加剧、喷射性呕吐、单侧瞳孔散大、意识模糊或新发肢体无力。

- ****药物不良反应****：发热/咽痛（提示白细胞减少）、皮肤瘀斑/牙龈出血（血小板减少）、肌肉酸痛（他汀类肌病）、过度镇静（日间嗜睡影响进食）。

- ****跌倒前驱表现****：站立时头晕、步态突然不稳、频繁抓握家具支撑。

- ****皮肤与消化道****：新发不明原因